



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA PONEK
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
SEPTEMBER 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LAPORAN KINERJA PONEK BULAN SEPTEMBER 2025

RS PRIMA HUSADA MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan ibu dan bayi baru lahir merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatal (AKN) masih menjadi tantangan besar, di mana banyak kematian tersebut disebabkan oleh komplikasi obstetri dan neonatal yang sebenarnya dapat dicegah melalui penanganan yang cepat dan tepat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, penyebab utama kematian ibu antara lain perdarahan, preeklampsia/eklampsia, infeksi, serta komplikasi persalinan, sementara kematian neonatal sering terjadi akibat asfiksia, infeksi, dan bayi berat lahir rendah (BBLR).

Untuk menurunkan AKI dan AKN, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengembangkan Layanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) sebagai upaya memperkuat sistem rujukan maternal dan neonatal. PONEK merupakan layanan terpadu di rumah sakit yang menyediakan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal 24 jam dengan tenaga kesehatan terlatih, fasilitas memadai, serta standar prosedur yang jelas. Implementasi layanan PONEK secara optimal diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

Rumah Sakit Prima Husada adalah sebuah Rumah Sakit Swasta tipe C yang terletak di Banjararum Selatan, Singosari, Malang. Rumah sakit berperan sebagai ujung tombak dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan juga berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas kesehatan maternal-neonatal di Indonesia dan mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat. Demi terselenggaranya keberhasilan PONEK diperlukan dukungan berbagai aspek krusial yang saling terkait, mulai dari penyediaan sumber daya manusia hingga penguatan sistem rujukan.

Pertama, rumah sakit menyiapkan tim medis khusus yang terdiri dari dokter spesialis obstetri-ginekologi, dokter anak, dokter anestesi, dan tenaga bedah, perawat dan bidan yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Kompetensi tim ini terus dijaga melalui program pelatihan berkala dan simulasi kasus gawat darurat. Infrastruktur menjadi pilar penting lainnya. Rumah sakit menyediakan ruang PONEK yang beroperasi 24 jam, dilengkapi dengan ruang bersalin, ruang operasi cesar, serta ruang perawatan intensif untuk ibu (PICU) dan bayi baru lahir (NICU). Kelengkapan alat medis, Laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan cepat dan bank darah yang siap pakai turut

mendukung kesiapan penanganan kasus emergensi. Sistem rujukan yang efektif dibangun melalui kerja sama erat dengan fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas dan klinik.

Protokol klinis yang jelas menjadi panduan tim medis dalam menangani berbagai komplikasi. Rumah sakit menyusun standar operasional prosedur untuk menangani perdarahan, eklampsia, sepsis, dan distosia persalinan, termasuk alur cepat untuk pasien kritis. Audit maternal-perinatal secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kualitas layanan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dukungan administratif dan pendanaan menjadi tulang punggung operasional PONEK. Rumah sakit mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan SDM, pemeliharaan alat, dan penyediaan obat-obatan emergensi.

Laporan bulanan ponek dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran pelayanan PONEK yang ada di RS Prima Husada Malang.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan layanan PONEK di Rumah Sakit harus berlandaskan peraturan dan undang undang yang berlaku, diantaranya :

1. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 126 dan 127**
2. Permenkes No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal: Undang- Undang dasar Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi:
3. Permenkes No. 3 Tahun 2022 tentang Standar Profesi Bidan:
4. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Penyelenggaraan PONEK:
5. Pedoman Nasional PONEK Kemenkes: Dokumen teknis yang berisi panduan pelaksanaan PONEK di fasilitas kesehatan
6. Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2014: Layanan PONEK termasuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang harus disediakan rumah sakit.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan serta mengutamakan keselamatan pasien.

1.3.2 Tujuan

1. Memberikan informasi pelayanan PONEK
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan PONEK
3. Menetapkan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan pasien dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

2.3 Motto

Sahabat menuju sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

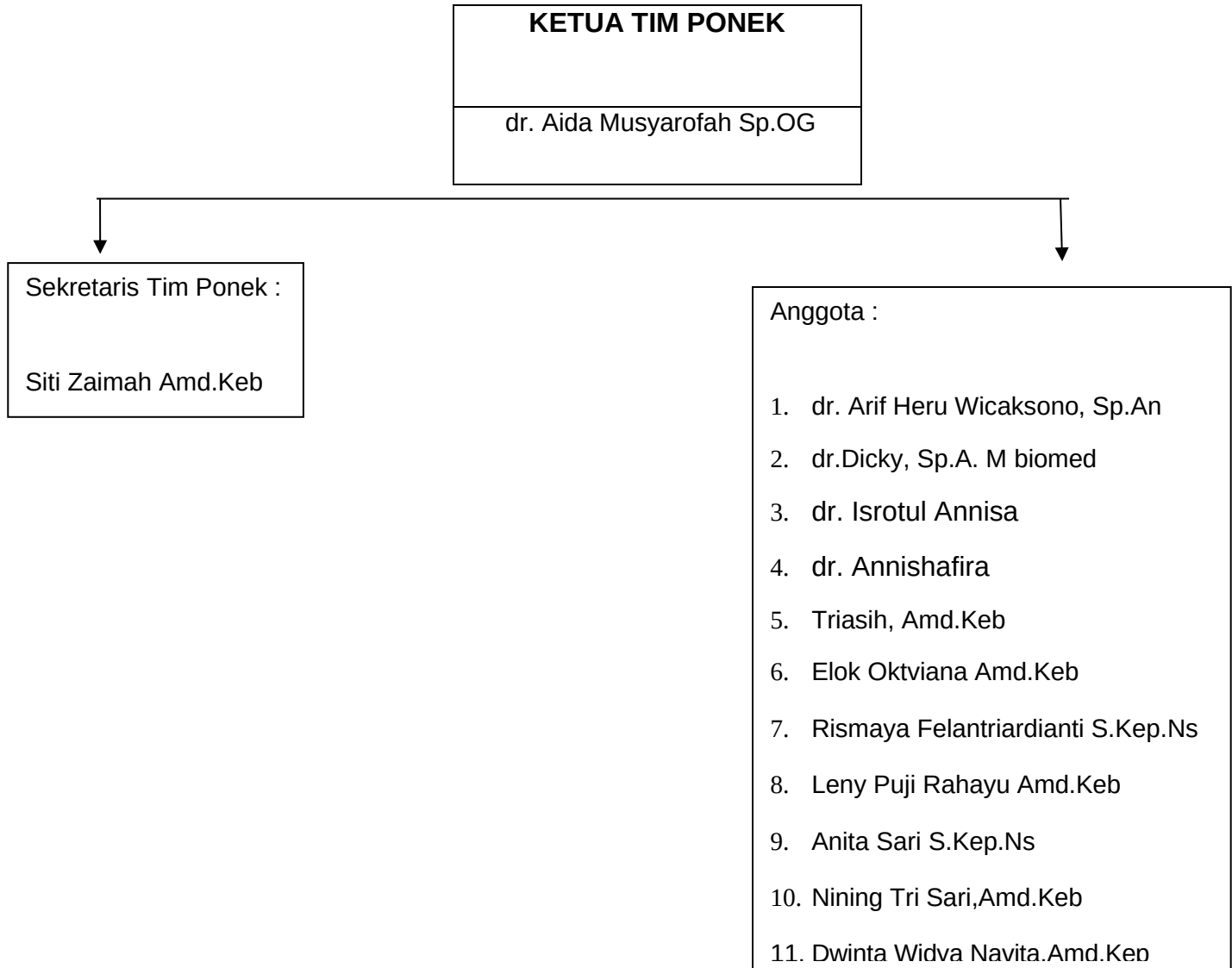
Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adii
7. Peduli

2.5 SOTK



STRUKTUR ORGANISASI TIM PONEK
RS PRIMA HUSADA MALANG



Analisa	- Jumlah Tim PONEK secara keseluruhan adalah berjumlah 11 orang. Masing - masing anggota memegang jabatan yang berbeda. - Program rotasi: Program rotasi tim PONEK berlaku bila kinerja anggota tidak memenuhi standart tim PONEK dan bila ada anggota yang resign. Pada bulan September tidak ada pergantian anggota Tim PONEK
Rencana Tindak lanjut	Koordinasi dengan Tim PONEK untuk mengembangkan pelayanan. Serta melakukan pelatihan inhouse training dan Drill Emergency terkait kegawat daruratan maternal Neonatal.

BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 Pola Ketenagaan

3.1.1 Jumlah SDM

Tabel 3.1.1 Jumlah SDM Tim Ponek RSPHM bulan September 2025

Jabatan	Jumlah SDM				Ket.
	Standar	Juli 2025	Agustus 2025	September 2025	
Ketua Tim Ponek	1	1	1	1	
Sekretaris Tim Ponek	1	1	1	1	
Anggota Tim Ponek	11	11	11	11	

3.1.2 Pemenuhan kualifikasi SDM

Tabel 3.1.2 Kualifikasi SDM RSPHM Tim Ponek RSPH September 2025

Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi	
	Standar	Ponek (Wajib)	PPGDON (Wajib)
Ketua Tim Ponek : dr. Aida Musyarofah Sp.OG	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
Sekretaris Tim Ponek : Siti Zaimah Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
1. dr. Arif Heru Wicaksono, Sp.An	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
2. dr. Dicky, Sp.A M biomed	Dokter	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
3. dr. Isrotul Annisa	Dokter	Sudah dilakukan	Belum dilakukan
4. dr. Annishafira	Dokter	Sudah dilakukan	Belum dilakukan
5. Triasih, Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
6. Elok Oktviana Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
7. Rismaya Felantriardianti S.Kep.Ns	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan
8. Leny Puji Rahayu Amd.Keb	Bidan	Sudah dilakukan	Belum dilakukan
9. Dwinta Widya Navita,Amd.Kep	Perawat	Sudah dilakukan	Belum dilakukan

3.1.4 Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM Tim Ponek di RSPH Malang Bulan September 2025

Tabel 1.4 Hasil Pelaksanaan Peningkatan SDM Tim Ponek di RSPH Malang Bulan September 2025

NO	Tema DIKLAT /WS/SEM/WB	Jenis Diklat	JUMLAH PESERTA		TGL Pelak sanaan	Hasil evaluasi dalam kinerja sehari-hari
			Hadir	Tidak Hadir		
1	Diklat Drill PONEK Kegawatdaruratan Maternal dan neonatal	Internal Profesi khusus	25	12	26-09-2025	- Kompeten dalam penanganan kasus maternal dan neonatal - Staf lebih cepat mengenali tanda-tanda awal kegawatan pada Maternal dan neonatal - Lebih sigap, tenang, dan profesional saat menangani kegawatdaruratan pada maternal dan neonatal - Keterampilan tim meningkat saat bekerja bersama (teamwork).

3.2. Fasilitas PONEK

Tabel 3.2. Fasilitas Ponek RSPHM bulan September 2025

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	USG Transport	Ruang tindakan	1 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
2	USG 4D	Poli kandungan	1	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 4/09/2025
3	IUD SET	Poli kandungan Ruang tindakan	2 set 2 set	Baik Siap Pakai	
4	Inkubator	Perinatologi	5 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
5	Cuvis	Perinatologi	4 unit	Baik Siap Pakai	
6	Monitor ECG	Ruang tindakan	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 2/9/2025
7	Box bayi	Perinatologi	15 unit	Baik Siap Pakai	
8	Fototerapi	Perinatologi	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
9	Suction bayi	Ruang tindakan/ IKO	1 set 1 set	Baik Siap Pakai	
10	Partus Set	Ruang tindakan	7 set	Baik Siap Pakai	
11	Curetage set	Ruang tindakan	4 set	Baik Siap Pakai	
12	Vacum manual	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
13	Timbangan bayi	Ruang tindakan, NICU, PONEK	3 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
14	NST/CTG	Ruang tindakan, PONEK	2 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/9/2025
15	Dopler	Ruang tindakan IGD Ponek	2 unit 1 Unit	2 unit baik 1 Unit	Kalibrasi 8/09/2025
16	Infarm warmer	Ruang tindakan. IKO IGD ponek	3 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 3/9/2025
17	Forsep	IKO	1 set	Baik Siap Pakai	
18	C-PAP Mesin	Perinatologi	5 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
19	Vakum set manual	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
20	AmbuBag Bayi	Ruang tindakan	3 set	Baik Siap Pakai	
21	Ambubag Dewasa	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
22	Larigoskop bayi dan anak	Ruang tindakan	1 set	Baik Siap Pakai	
23	Oxymetri neonates	Ruang perinatologi	1 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
24	Pulse oksimetri neonates baru	Ruang Perinatologi	4 unit	Baik Siap Pakai	Kalibrasi 8/09/2025
25	Sendok kuret makro no 8 dan 10	Ruang Tindakan	2 unit	Baik siap pakai	
26	Micro curret	Ruang Tindakan	1 unit	Baik siap pakai	
27	Sendok Curret	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	

No	Jenis	Ruangan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
28	HPP set	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
29	Busi kecil	Ruang Tindakan	2 set	Baik siap pakai	
30	Busi besar	Ruang Tindakan	1 set	Baik siap pakai	
31	Spekulum besar	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
32	Spekulum sedang	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
33	Spekulum kecil	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik siap pakai	
34	Nalfuder No 20	Ruang Tindakan	1 Unit	Baik Siap pakai	
35	Inkubator transport	Ruang Perinatologi	1 Unit	Baik Siap pakai	Kalibrasi 8/09/2025

Analiasa	1) Secara umum kondisi fasilitas dan peralatan PONEK cukup lengkap, Khusus alat penunjang medis yang elektrik sudah terkalibrasi 2) Secara bertahap fasilitas alat PONEK mulai di perbaharui dan alat yang belum tersedia sesuai perencanaan dalam RKA 2025 3) Untuk alat yang rusak, kerjasama perbaikan oleh tim IPSRS 4) Pada bulan September ada jadwal kalibrasi
Rencana Tindak lanjut	1) Melakukan pengecekan alat setiap 1 bulan sekali oleh PJ alat di supervise oleh karu 2) Melakukan pemeliharaan alat secara berkala setiap 1 bulan sekali oleh IPSRS 3) Melakukan kalibrasi setiap 1 tahun sekali

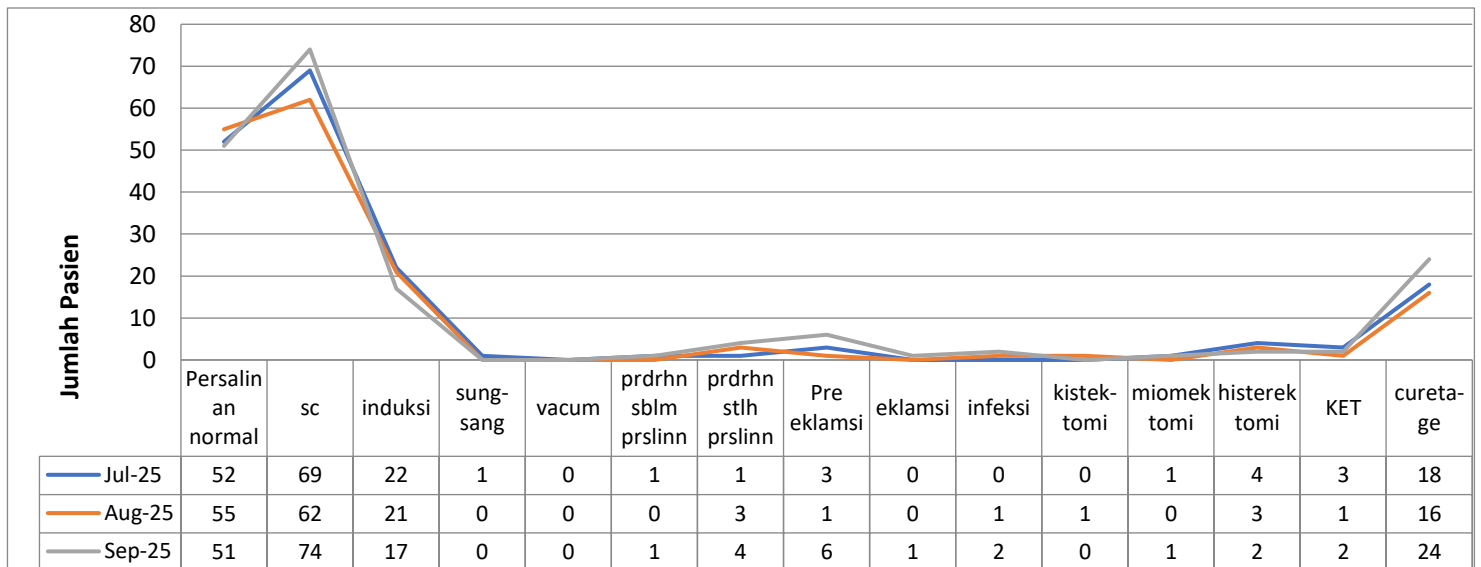
3.3 Kinerja Produktivitas

3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal

Tabel 3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponék RSPHM September 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	52	55	51
	b. <i>SectioCaesaria</i>	69	62	74
2				
	a. Induksi / Drip	22	21	17
	b. Sungsang	1	0	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	1	0	1
	b. Perdarahan setelah Persalinan	1	3	4
	c. Pre Eklamsi	3	1	6
	d. Eklamsi	0	0	1
	e. Infeksi	0	1	2
4				
	a. Curretage	18	16	24
	b. Kistektomi	0	1	0
	c. Miomektomi	1	0	1
	d. Histerectomy	4	3	2
	e. KET	3	1	2

Grafik 3.3.1
Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi :

- 1) Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan September 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 74 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan September 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 51 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu. Jumlah persalinan secara SC dan Persalinan normal pada bulan September sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah pasien di maternitas juga meningkat pada bulan September 2025.
- 2) Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
- 3) Tidak ada persalinan sungsang pada bulan September 2025, sedangkan pada bulan Juli 2025 ada 1 persalinan sungsang. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan September 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
- 4) Induksi Persalinan pada bulan September mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 17 pasien
- 5) Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 6 pasien. Dan ada 1 kejadian eklamsi pada bulan September 2025.

- 6) Jenis pelayanan curetage di bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 24 pasien. Curetage dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

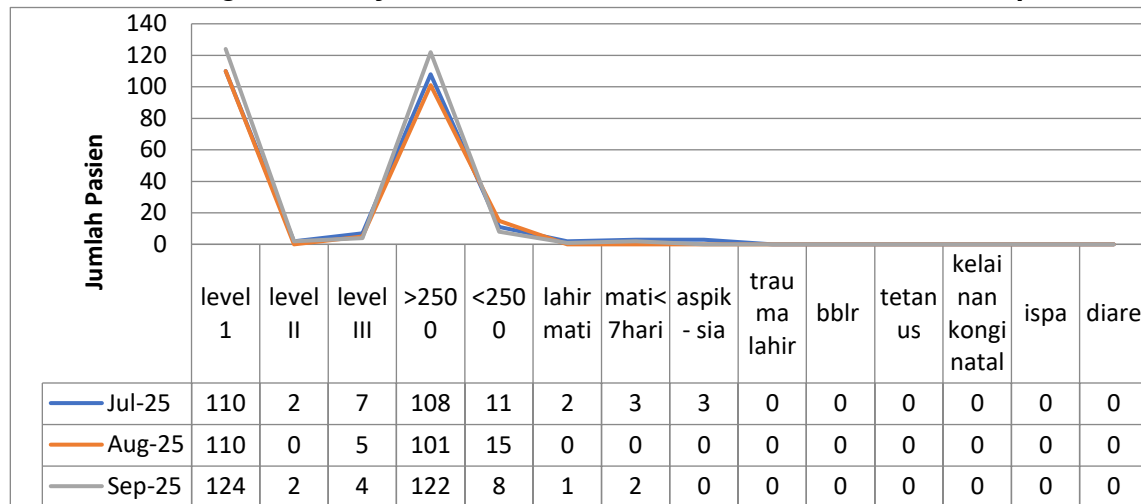
3.3.2. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

Tabel 3.3.2 tabel jumlah kegiatan pelayanan neonatal Ponek RSPHM September 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1				
	f. Level 1	110	110	124
	g. Level II	2	0	2
	h. Level III	7	5	4
2				
	a. ≥ 2500 gram	108	101	122
	b. ≤ 2500 gram	11	15	8
3				
	a. Kelahiran Mati	2	0	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	3	0	1
4				
	a. Asphyxia	3	0	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	11	15	8
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

Grafik 3.3.2

Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi

- 1) Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 124 bayi. Dan untuk pelayanan level 2 pada bulan September sebanyak 2 bayi, sedangkan pada level 3 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 4 bayi. Jumlah bayi bulan September 2025 meningkat seiring dengan jumlah persalinan pada bulan September 2025
- 2) Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 122 bayi.
- 3) Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan September 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 8 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
- 4) Kasus BBLR pada bulan September 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 8 bayi.
- 5) Ada 1 kasus kelahiran mati pada bulan September 2025, sedangkan pada bulan Agustus tidak ada kasus, dan Juli sebanyak 2 kasus.
- 6) Ada 2 kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan September, sedangkan pada bulan Agustus tidak ada kasus, dan Juli sebanyak 3 kasus.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2) Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
- 3) Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

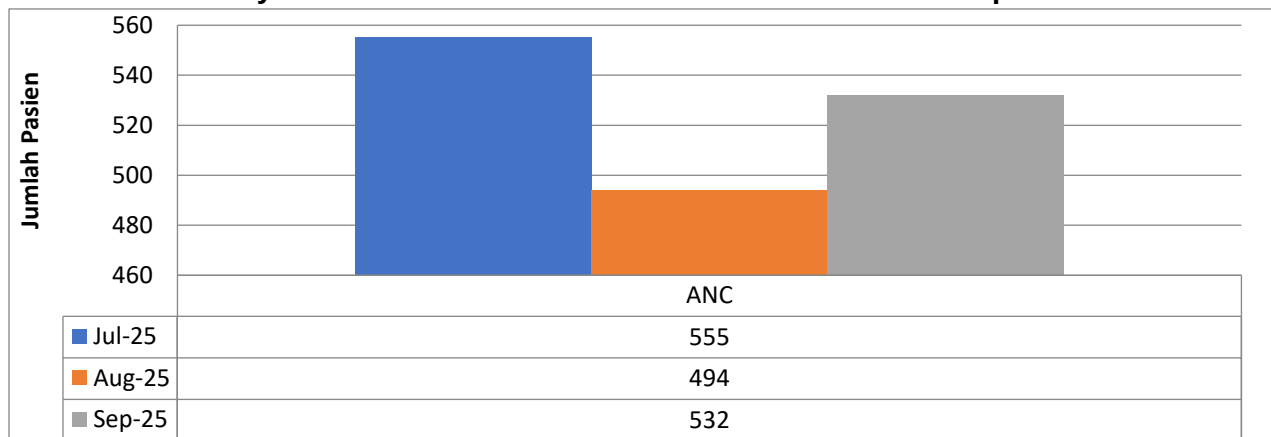
3.3.3. Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

Tabel 3.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponek RSPHM September 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1	ANC	555	494	532

Grafik 3.3.3

Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi

Pelayanan ANC pada bulan September 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 532 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut

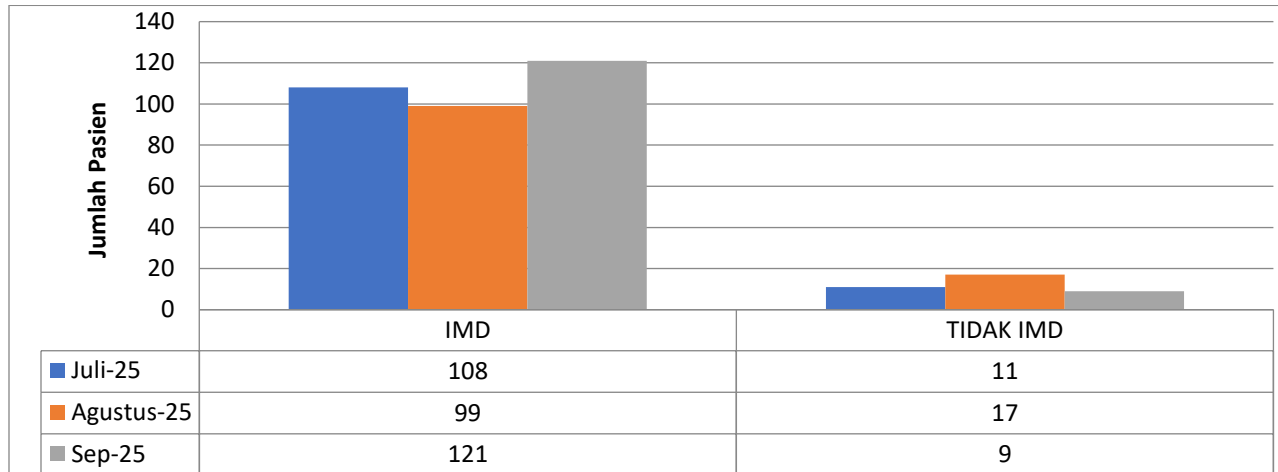
- 1) Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.3.4. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel 3.3.4 Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) September 2025

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1	IMD	108	99	121
2	Tidak IMD	11	17	9

Grafik 3.3.4
Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi

- 1) Bayi yang dilakukan IMD pada bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 122 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2) Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan September menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 9 bayi, Sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 17 bayi, dan Juli sebanyak 11 bayi.
- 3) Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan September 2025

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
1	By Ny Anggun Ratna Sari	Imatur + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP
2	By Ny Dewita Oktari	NCB, BBLR	Cuvis
3	By Ny Lia Rosalina	NP-Spt+ BBLASR+ obs.dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Inkubator + CPEP
4	By Ny Meila kartika	NCB, BBLR, HIPOGLIKEMI REFRAKTER	Cuvis
5	By Ny Milyuni	NKB, BBLR	Cuvis
6	By Ny Mugiasih	NKB, BBLR	Cuvis
7	By Ny Putri wulandari	RDS OK HMD, Neonatal Pneumonia	Inkubator + CPEP
8	By Ny Reza Vanny	RDS +BBLR, Prematur	Inkubator + CPEP

9	By Ny Ria Stifani	RDS OK HMD, Neonatal Pneumonia	Inkubator + CPEP
---	-------------------	--------------------------------	------------------

- 4) Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

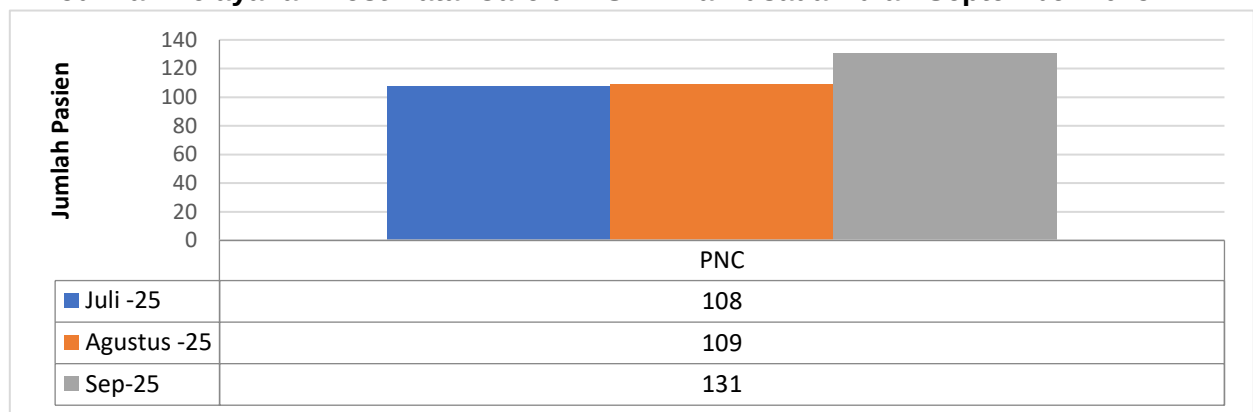
3.3.5. Pelayanan Post Natal Care (PNC)

Tabel 3.3.5 Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek RSPHM September 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1	PNC	108	109	131

Grafik 3.3.5

Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi

Pelayanan PNC pada bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 131 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut

Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

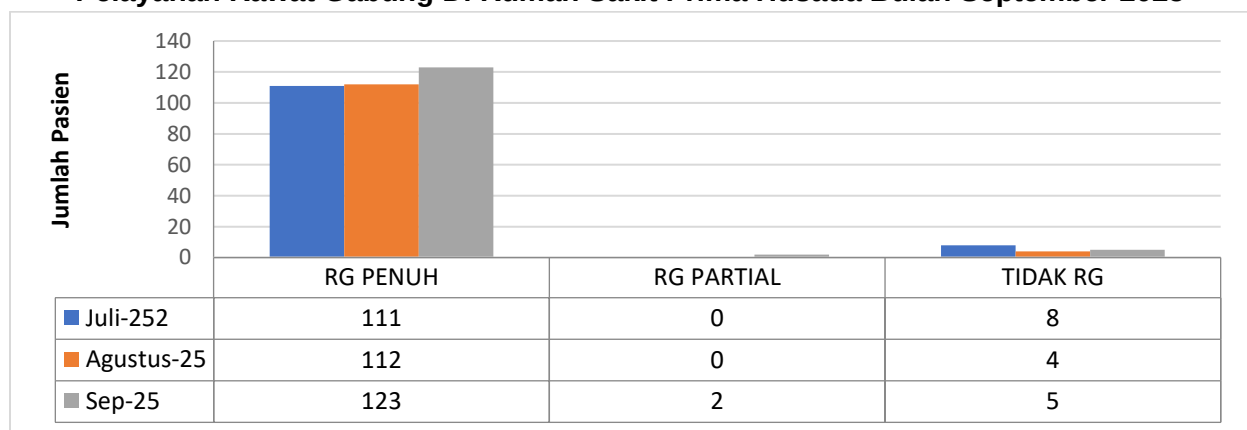
3.3.6. Pelayanan Rawat Gabung

Tabel 3.6 Pelayanan Rawat Gabung Ponek RSPHM September 2025

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1	Rawat gabung penuh	111	112	123
2	Rawat gabung partial	0	0	2
3	Tidak Rawat gabung	8	4	5

Grafik 3.3.6

Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi

- 1) Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 123 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan September 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 5 bayi.
- 3) Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

No	Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
1	By Ny Anggun Ratna Sari	Imatur + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP
2	By Ny Lia Rosalina	NP-Spt+BBLASR+ obs.dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Inkubator + CPEP
3	By Ny Reza Vanny	RDS +BBLR, Prematur	Inkubator + CPEP
4	By Ny Putri wulandari	RDS OK HMD, Neonatal Pneumonia	Inkubator + CPEP

5	By Ny Ria Stifani	RDS OK HMD, Neonatal Pneumonia	Inkubator + CPEP
---	-------------------	--------------------------------	------------------

- 4) Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan skrining awal untuk bayi yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

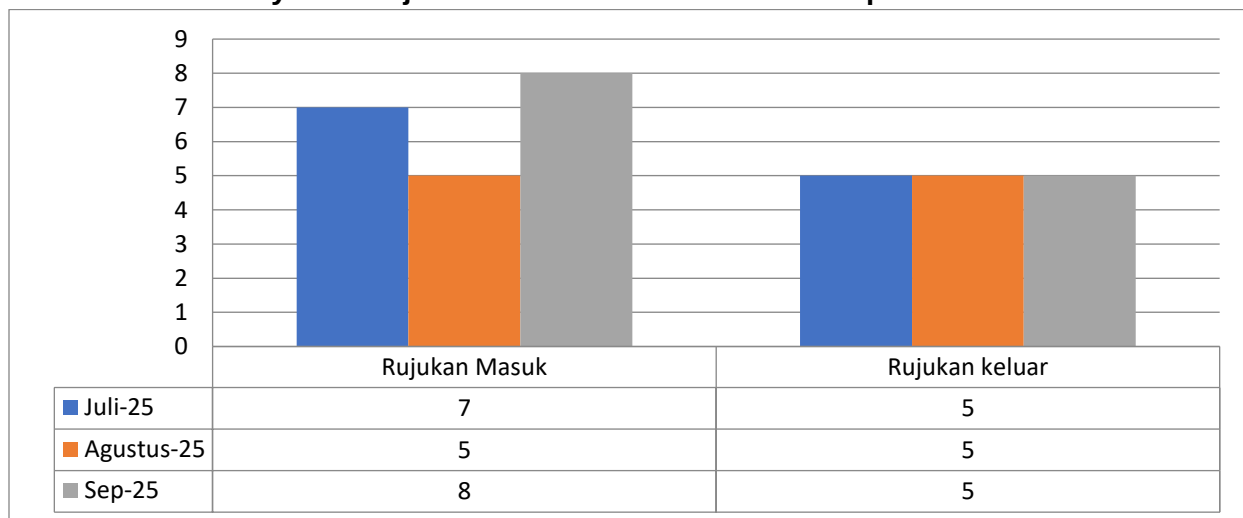
3.3.7. Pelayanan Jejaring Rujukan

Tabel 3.3.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Ponpek RSPHM September 2025

No	Rujukan	Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1	Rujukan Masuk	7	5	8
2	Rujukan keluar	5	5	5

Grafik 3.3.7

Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan September 2025

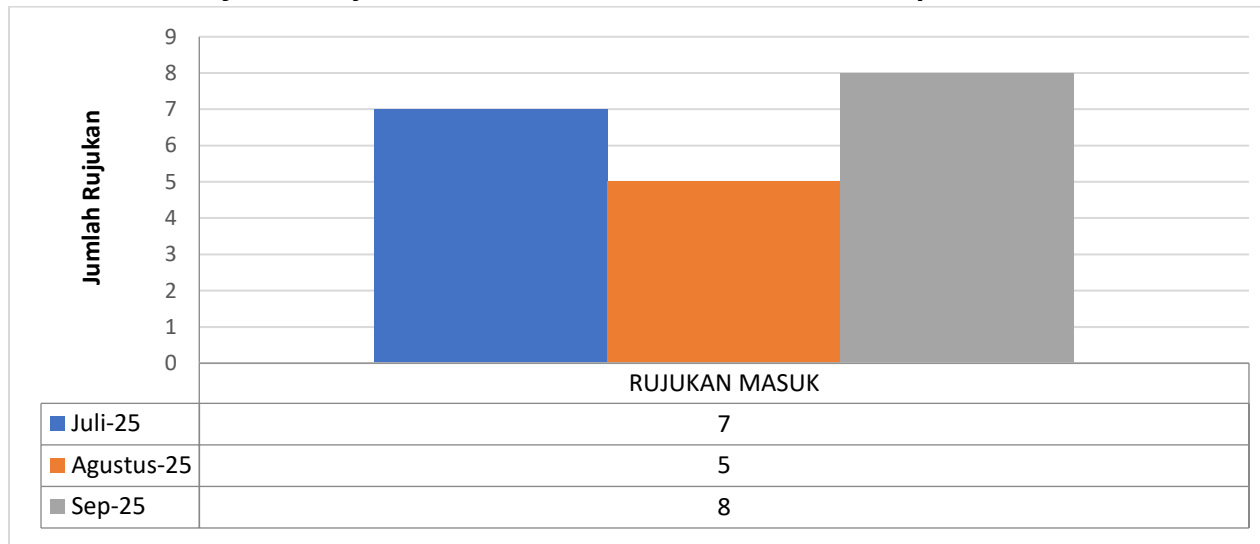


3.3.7.1 Rujukan Masuk

Tabel 3.3.7.1 Rujukan Masuk Ponpek RSPHM September 2025

Bulan Juli 2025			
1	By Ny Marita	Asfiksia	PMB Tri
2	Ny Anis Puspita Sari	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg PEB	PKM Singosari
3	Ny Evi Yuniarti	G3 P2002 Ab000 UK 40-41 mgg dg KPD + KIFL	PKM Ardimulyo
4	Ny Nurul Sa'adah	G2 P1001 Ab000 Uk 8-10 mgg dg Abotus Inkomplit	PMB Tri W
5	Ny Dita Puri A	G1 P0000 Ab000 Uk 38-39 mgg dg KIFA	Klinik Mutiara Sehat
6	Ny Shifatul Husni	G1 P0000 Ab000 Uk 41-42 mgg dg KIFL	PMB Titik Sunaryati
7	Ny Vira	G1 P0000 Ab000 Uk 34-36 mgg dg PEB	Klinik Muslimat
Bulan Agustus 2025			
1	By Ny Nur Fitri	RDS	PMB Tri W
2	Ny. Illa Rodhiyah	G4 P1103 AB100 UK 10-12 Mgg dg Abortus Inkomplit	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Siska A	G1 P0000 AB 0 UK 32-34 MGG dg kala 2	PKM Singosari
4	Ny Siti Nur H	G1P000 AB00 UK 39-40 Mgg dg kala 2	PKM Lawang
5	Ny Widya A	G1 P0000 AB000 UK 32-34 Mgg dg PPR0M	Klinik Mutiara Sehat
Bulan September 2025			
1	By Ny Sri bawon 1	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	RS Sumber Santosa
2	By Ny Sri bawon 2	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	RS Sumber Santosa
3	By By Erwin	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	PKM Singosari
4	By Rayyan Maulana	PNEUMONIA, NEC, BBLSR	RS Sahabat
5	Ny Erwin	P2103 Ab000 dengan post partum + HPP ec sisa plasenta	PKM Singosari
6	Ny Meila	G3 P0010 Ab100 UK 36-37 mgg dg HT+ DM+BOH	PMB Titik Sunaryati
7	Ny Nur Halimatus	G1 P0000 Ab000 UK 39-40 mgg dg KPD	PMB Titik Sunaryati
8	Ny Cholis Ambiyah	G2 P1001 Ab000 UK 40-41 mgg dengan PEB +KPD	PKM Singosari

Grafik 3.3.7.1
Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi :

- 1) Jumlah rujukan masuk pada bulan September meningkat yaitu 8 rujukan, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 5, dan Juli 2025 7 rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM, Puskesmas, Klinik dan RS setempat untuk bekerja sama.

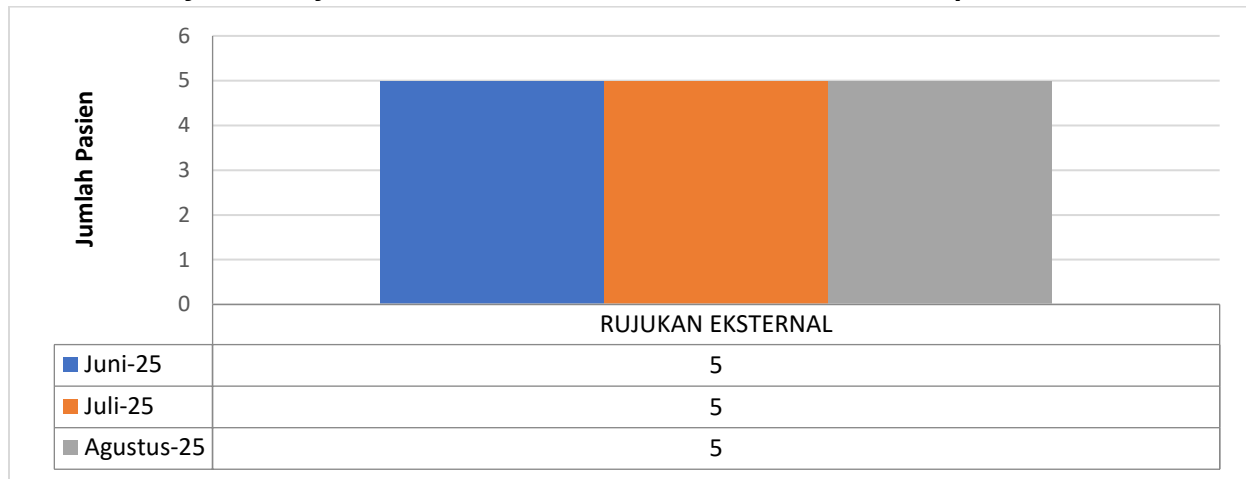
3.3.7.2 Rujukan Keluar

Tabel 3.3.7.2 Rujukan Keluar Ponak RSPHM September 2025

Bulan Juli 2025						
1	Stefia Shallom	16 th	IGD	Abdominal pain susp Neoplasma Ovarial	Pro laparatomi back up bedah digestive	RS Saiful Anwar
2	By Ny Manda Kumalasari	3 hari	NICU	RDS + BBLR	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Saiful Anwar
3	By Ny Nadia	4 hari	NICU	RDS + BBLSR + NKB	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
4	By Ny Marita	1 hari	NICU	RDS + Susp DS	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	By Ny Retnosari	1 hari	NICU	RDS + Bronchopneumonia + NEC	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette

Bulan Agustus 2025						
1	Riyanti	41 Th	Maternitas	P2103 Ab000 dg Post SC+MOW hari ke 2 a/l Inpending eklamsi + anuria	Pro Hemodialisa	RS Saiful Anwar
2	Nn Nafisa	17 Th	Irna 5C	Susp Internal bleeding ec KET + trombositopenia + anemia	Pro Laparatomy cito dg backup transfusi TC	RS Saiful Anwar
3	By Ny Wikke	1 hr	NICU	NKB + BBLR	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
4	By Ny Nur Aini	2 hr	NICU	NCB + Pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	By Ny Nur Fitri	3 hr	NICU	RDS	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Saiful Anwar
Bulan September 2025						
1	By Ny Apsah	3 hr	NICU	Bronchopneumonia + Hipoglikemia refrakter	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
2	By Ny Lia	3 hari	NICU	NP-Spt + BBLASR + obs. dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
3	By Ny Erwin	1 hari	NICU	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Soepraoen
4	By Ny Sri bawon 2	1 hari	NICU	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	Ny Lilis	38 th	PONEK	G2 P0000 AB100 UK 30-32 mgg dengan Eklamsi + HT emergency + nprimi tua sprimer + riwayat infertile +HSVB	Penanganan lebih lanjut	RS Saiful Anwar

Grafik 3.7.2
Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi :

Pada bulan September dan 2 bulan sebelumnya jumlah rujukan eksternal sama yaitu 5 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut

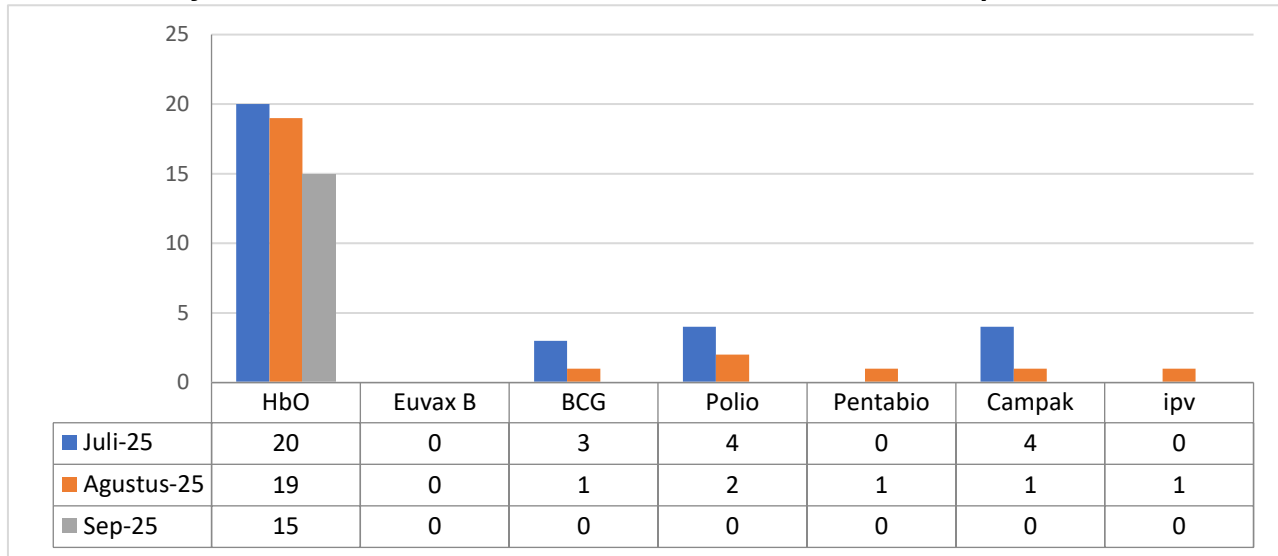
Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.3.8. Pelayanan Imunisasi

Tabel 3.3.8 Pelayanan Imunisasi Ponek RSPHM September 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1	HbO	20	19	15
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	3	1	0
3	Polio	4	2	0
4	Pentabio	0	1	0
5	Campak	4	1	0
6	IPV	0	1	0

Grafik 3.3.8
Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi

- 1) Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode September 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
- 2) Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan September sebanyak 15 bayi, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 19 bayi, dan bulan Juli sebanyak 20 bayi. Hal ini dikarenakan minimnya ketidakterseediaanya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
- 3) Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan September dan Juli, sedangkan bulan Agustus sebanyak 1 bayi.
- 4) Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan September, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 1 bayi, dan Juli sebanyak 3 bayi.
- 5) Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Campak pda bulan September, sedangkan bulan Agustus sebanyak 1 bayi, dan pada bulan Juli sebanyak 4 bayi,
- 6) Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan September, sedangkan bulan Juli sebanyak 4 bayi.
- 7) Tidak ada bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan September dan Juli, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 1 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2) Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

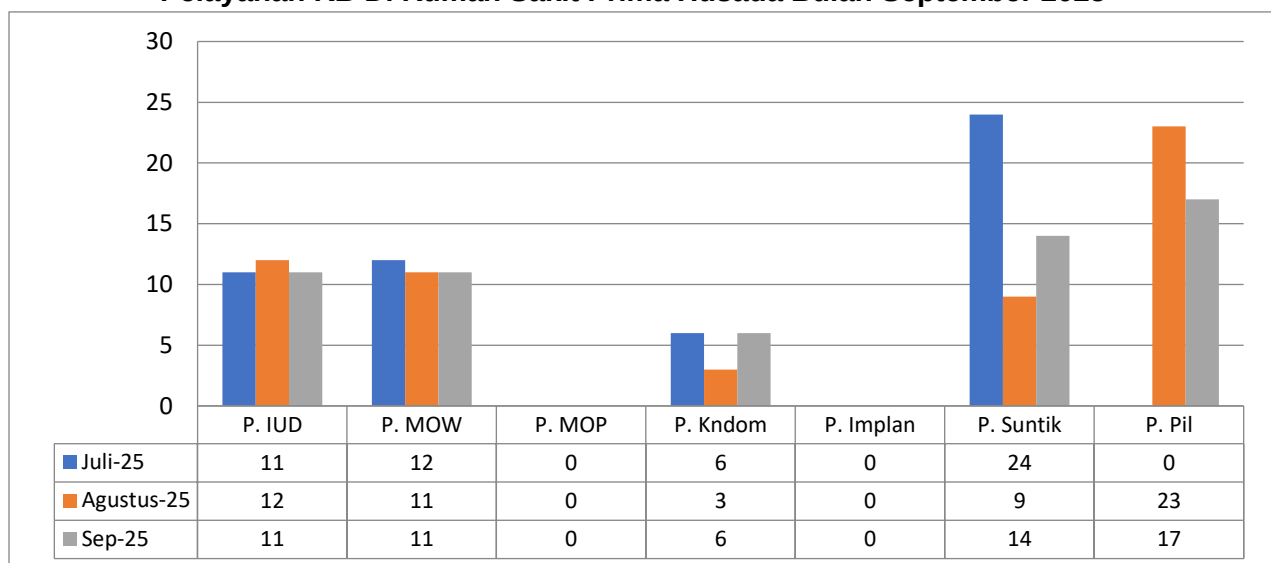
3.3.9. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

**Tabel 3.3.9.1 Pelayan Pemasangan Keluarga berencana (KB) Ponok RSPHM
September 2025**

No	Jenis	Jumlah Pasang		
		Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1	IUD	11	12	11
2	MOW	12	11	11
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	6	3	6
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	24	9	14
7	Pil	0	23	17

Grafik 3.3.9.1

Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi

- 1) Pemasangan KB IUD pada bulan bulan September 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 11 akseptor yang terdiri dari 6 akseptor IUD Nova T dan 5 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2) Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan September 2025 sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 pasien, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 12 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3) Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan September sama dengan bulan Juli yaitu 6 pengguna, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 6 pengguna
- 4) Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan September sebanyak 17 pengguna, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 23 pengguna, dan Juli tidak ada.
- 5) Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan September meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 14 pengguna, sedangkan bulan Agustus sebanyak 9 pengguna dan sedangkan bulan Juli sebanyak 24 pengguna

Rencana dan Tindak Lanjut

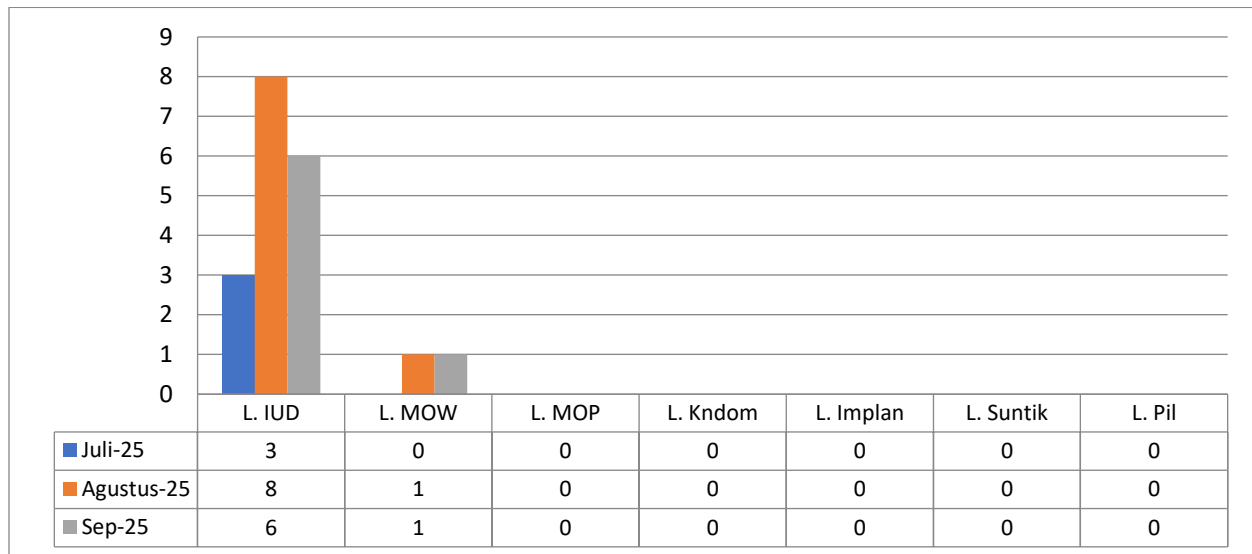
- 1) Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3.9.2 Pelayanan Pelepasan Keluarga Berencana (KB)

Tabel 3.3.9.2 Pelayan Pelepasan Keluarga berencana (KB) Ponok RSPHM September 2025

No	Jenis	Jumlah Lepas		
		Juli 2025	Agustus 2025	September 2025
1	IUD	3	8	6
2	MOW	0	1	1
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0

Grafik 3.3.9.2
Pelayanan Pelepasan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi

1. Pelepasan KB IUD pada bulan September menurun yaitu 6 Akseptor, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 8 akseptor, dan Juli yaitu 3 Akseptor
2. Ada 1 pelepasan KB Implan pada bulan Agustus dan september, sedangkan Juli tidak ada

Rencana dan Tindak Lanjut

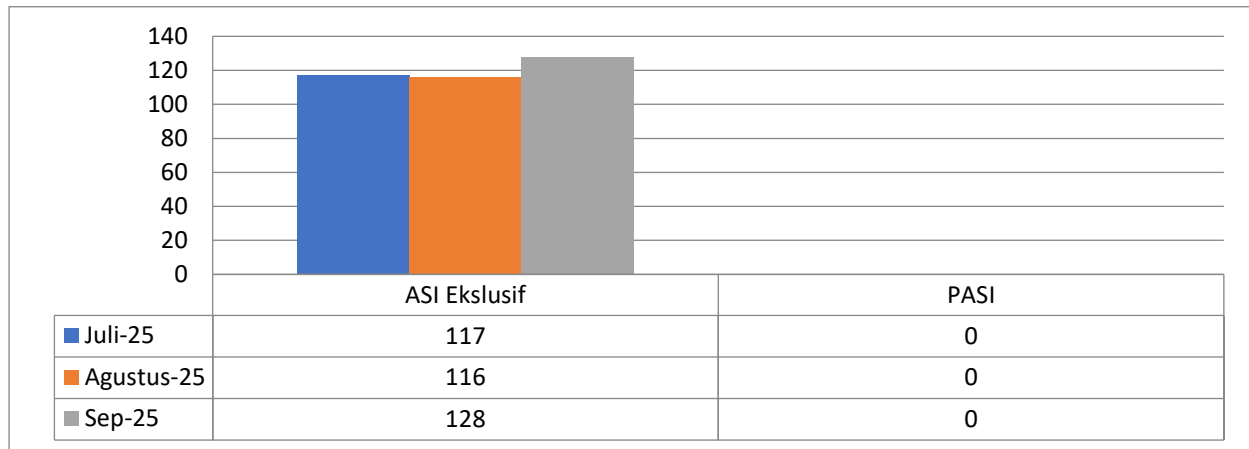
- 1) Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3.10. Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 3.3.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponpek RSPHM September 2025

No	Pemberian Asi	Jumlah Pasien		
		Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1	Asi eksklusif	117	116	128
2	PASI	0	0	0

Grafik 3.3.10
Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi

- 1) Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan September meningkat yaitu 128 bayi, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 117 bayi, dan Juli sebanyak 117 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2) Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan September dan 2 bulan sebelumnya. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut

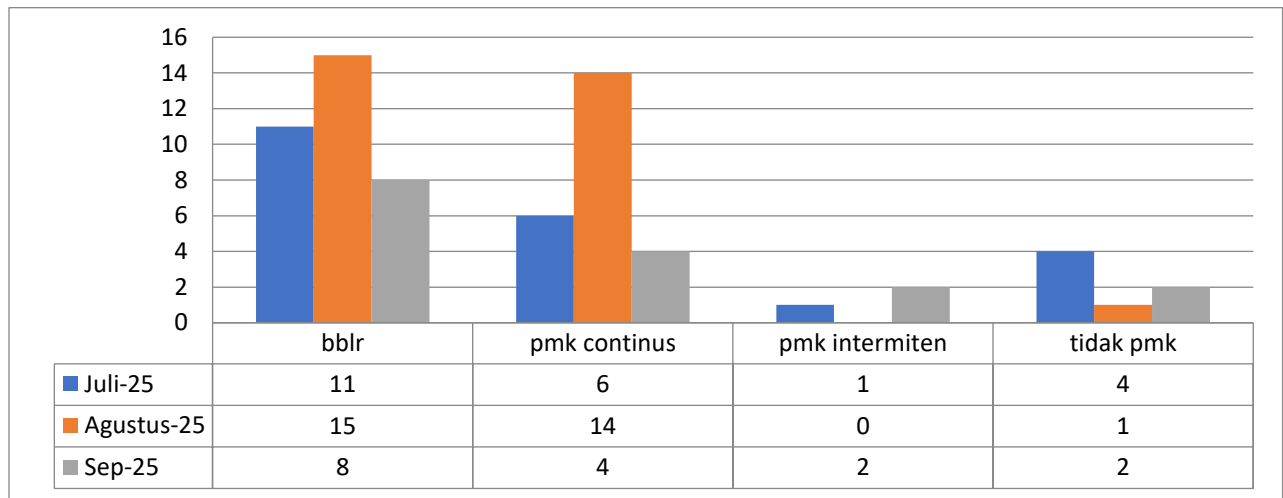
- 1) Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.3.11. Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel 3.3.11 Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponok RSPHM Bulan September 2025

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1	Bayi BBLR	11	15	8
2	PMK continuos	6	14	4
3	PMK Intermiten	1	0	2
4	Tidak PMK	4	1	2

Grafik 3.3.11
Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Di RS Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi

- 1) Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2) Ada 2 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan September, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 1 bayi. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
- 3) Sedangkan metode PMK continus pada bulan September menurun yaitu 4 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil, sedangkan pada bulan Agustus 2025 sebanyak 14 bayi, dan bulan Juli 2025 sebanyak 6 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4) Ada 2 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan September, sedangkan pada bulan Agustus ada 1 bayi, dan Juli ada 4 bayi.
 Berikut daftar bayi yang tidak dilakukan PMK

No	Nama	Diagnosa	Perawatan BBL	Alasan
1	By Ny Anggun Ratna Sari	Imatur + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP	meninggal
2	By Ny Lia Rosalina	NP-Spt+ BBLASR+ obs.dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Inkubator + CPEP	Rujuk

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

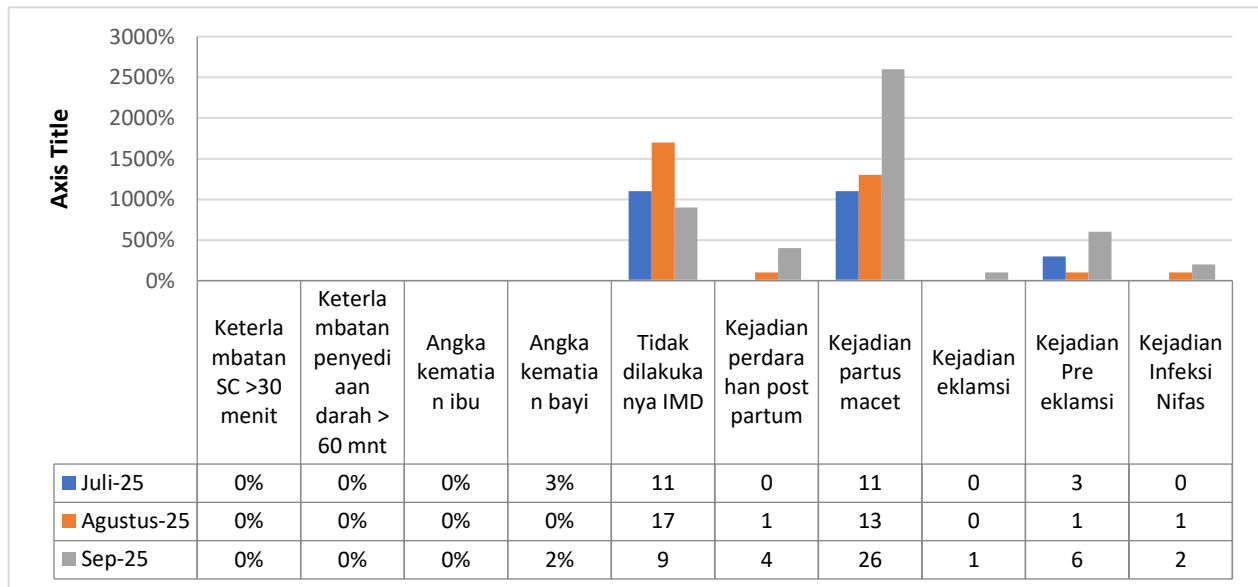
3.4 MUTU

Tabel 3.4 MUTU Ponek RSPHM Mutu bulan September 2025

No	Pengukuran Mutu	Standart	Bulan Juli 2025	Bulan Agustus 2025	Bulan September 2025
1	Angka keterlambatan operasi section caesaria (SC) >30 menit	<0%	0%	0%	0%
2	Angka keterlambatan penyediaan darah (> 60 menit)	<10%	0%	0%	0%
3	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%
4	Angka kematian bayi	0%	3 %	0 %	2%
5	Kejadian tidak dilakukanya IMD (Inisiasi Menyusui Dini) pada bayi baru lahir	0	11	17	9
6	Kejadian perdarahan post partum	0	0	1	4
7	Kejadian partus macet	0	11	13	26
8	Kejadian eklamsi	0	0	0	1
9	Kejadian Pre eklamsi	0	3	1	6
10	Kejadian Infeksi Nifas	0	0	1	2

Grafik 3.4

Mutu PONEK Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi :

- 1) Pada Mutu Angka kematian Ibu pada bulan September 2025 maupun 2 bulan sebelumnya sebanyak 0 %. Hal ini dikarenakan tidak ada kejadian kematian pada maternal pada bulan tersebut.
- 2) Pada Mutu Angka kematian Bayi pada bulan September 2 %, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 3 %, Hal ini dikarenakan ada 2 kasus kematian pada Neonatal pada bulan September
- 3) Pada mutu tidak dilakukannya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir, Pada bulan September sebanyak 9 bayi, sedangkan bulan Agustus sebanyak 17 bayi, dan bulan Juli sebanyak 11 bayi.
- 4) Berikut alasan kenapa bayi tidak dilakukannya IMD pada bulan September 2025

No	Nama	Diagnosa	Perawatan
1	By Ny Anggun Ratna Sari	Imatur + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP
2	By Ny Dewita Oktari	NCB, BBLR	Cuvis
3	By Ny Lia Rosalina	NP-Spt+ BBLASR+ obs.dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Inkubator + CPEP
4	By Ny Meila kartika	NCB, BBLR, HIPOGLIKEMI REFRAKTER	Cuvis
5	By Ny Milyuni	NKB, BBLR	Cuvis
6	By Ny Mugiasih	NKB, BBLR	Cuvis
7	By Ny Putri wulandari	RDS OK HMD, Neonatal Pneumonia	Inkubator + CPEP
8	By Ny Reza Vanny	RDS +BBLR, Prematur	Inkubator + CPEP
9	By Ny Ria Stifani	RDS OK HMD, Neonatal Pneumonia	Inkubator + CPEP

Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir dikarenakan bayi lahir dengan BBLR kurang bulan dan Asfiksia, sehingga bayi memerlukan tindakan segera untuk pemasangan alat bantu CPAP dan perawatan incubator. Oleh karena itu bayi tidak dilakukannya IMD. Perawat bayi melakukan IMD sesuai dengan syarat yang telah ditentukan kecuali pada bayi dengan kondisi asfiksia sedang-berat dan kelainan konginetal, pada TM III terjadi peningkatan pada kasus ini, bayi tidak di IMD yang disebabkan karena BBLR dan asfiksia sedang-berat yang membutuhkan perawatan incubator, C-pap dan oksigen.

- 5) Pada kasus pasien pre eklamsi pada bulan September sebanyak 6 kasus, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 1 kasus, dan bulan Juli sebanyak 3 kasus. Unit terkait akan berkolaborasi dengan SP.OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko

untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi.

- 6) Pada kasus Kejadian partus macet pada bulan September sebanyak 26 kasus, sedangkan bulan Agustus sebanyak 13 kasus, dan bulan Juli sebanyak 11 kasus. Kejadian partus macet pada bulan September dikarenakan prolong fase laten, prolong fase aktif, dan kala 2 lama, sehingga pasien dilakukannya operasi SC.
- 7) Ada 4 Kejadian perdarahan post partum pada bulan September, sedangkan bulan Agustus 2025 sebanyak 1 kejadian , sedangkan pada bulan Juli tidak ada kejadian. Kejadian perdarahan post partum pada bulan Agustus disebabkan karena atonia uteri dan sisa plasenta.
- 8) Ada 2 kejadian Infeksi nifas pada bulan September, sedangkan pada bulan Agustus ada 1 kejadian, dan Juli tidak ada kejadian.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makanan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) berkolaborasi dengan SP. OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi
- 4) Memberikan Edukasi pada Ibu post Nifas terkait gizi yang dibutuhkan ibu Nifas, agar tidak terjadi lagi kasus infeksi pada Ibu nifas.
- 5) Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah Kunci indikator mutu PONEK.
- 6) Koordinasi dengan Tim PMKP untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan dilaporkan ke direktur Rumah Sakit.

3.5 Kelas Senam hamil

Kelas senam hamil

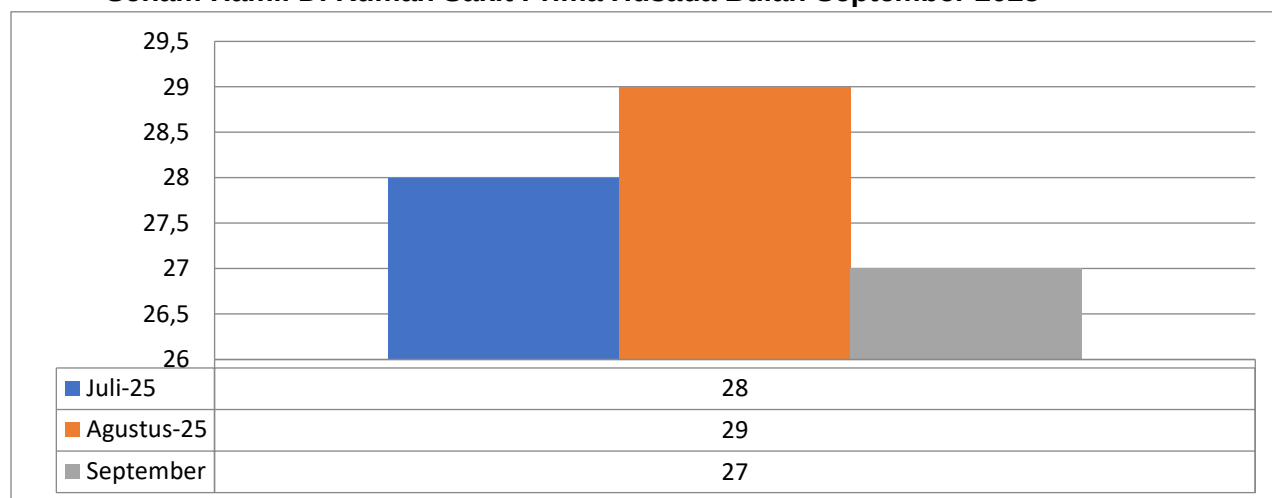
Tabel 3.5 Kelas senam hamil RSPHM September 2025

Pengembangan Pelayanan	Hasil kinerja	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
Senam Hamil	- Minggu ke 2 : Anggota : 30 peserta Hadir : 14 peserta. - Minggu ke 4 : Anggota: 30 peserta Hadir : 13 peserta	Rata-rata kehadiran bulan September senam hamil 45% Total persalinan 75% dari senam hamil yang diselenggarakan di PHM, dengan senam hamil ini dapat menambah citra RS yang lebih baik, menambah kunjungan dan semakin	- Berkolaborasi dengan asisten Poli Obgyn untuk mengedukasi pasien hamil uk diatas 22 minggu untuk mengikuti senam hamil. - KIE bahwa kelas senam teradapat Hypnopregnancy yang

	.Target : 1 bulan 2 kali. Hasil : 2x/bulan = bumil	banyak orang yg menyukai RS Prima Husada Malang. Jumlah peserta senam hamil masih belum mencapai target dengan jumlah peserta setiap datang target 30 peserta,.	akan kontinyus dg hypno melahirkan. Video Promosi senam hamil yang di tampilkan di IG RS dan di prima menyapa
--	--	---	---

Grafik 3.5.1

Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2025



Evaluasi :

1. Peserta senam hamil pada bulan September sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 27 peserta, 29 peserta pada bulan Agustus dan 28 peserta pada bulan juli.
2. Peserta senam hamil pada bulan September yang melahirkan 8 pasien, 5 pasien melahirkan di RS Prima Husada, 3 pasien melahirkan di faskes lain.
3. Dari 8 peserta senam hamil yang melahirkan, 8 pasien mengatakan pada proses persalinan senam hamil dan hypnoterapi sangat membantu.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1) Melakukan penjarangan ibu hamil usia kehamilan 22-24 minggu untuk melakukan senam hamil.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil di ruang tunggu poli untuk melakukan senam hamil
- 3) Berkolaborasi dengan PKRS membuat flayer promosi senam hamil yang ditempatkan di ruang tunggu poli obgyn
- 4) Membuat video promosi senam hamil yang di putar di prima menyapa dan di upload di IG RS
- 5) Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah peserta senam hamil.

-
- 6) Koordinasi dengan Tim PKRS untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan dilaporkan ke direktur Rumah Sakit.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring

Tabel 4. 1. Hasil Monitoring atau supervise Ponек RSPHM September tahun 2025

No	Bulan	Kegiatan	Jumlah yang dipantau/ diobservasi	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
1	September	Diklat Kegawatan Maternal Neonatal	8	Dari dinas kesehatan diminta dokter umum mempunyai sertifikat kegawatan maternal neonatal	dokter umum di RS prima Husada belum ada yang mempunyai sertifikat kegawatan maternal neonatal	Koordinasi dengan SDM dan Kabid pelayanan Medis	SDM	

4.2.Evaluasi

Tabel 4.2. Hasil evaluasi Ponек 2025

Bulan	Masalah yg dibahas	Hasil Temuan	Akar Masalah	RTL	PIC	Ket
Septem ber	Pelayanan Imunisasi	Bayi baru lahir tidak mendapatka n imunisasi HB0	1. Vaksin Hb0 di puskesmas terbatas, bulan September bayi baru lahir yang mendapatkan vaksin HB0 yaitu 15 pasien ,sedangkan jumlah kelahiran bulan September 121 bayi. 2. Pasien yang melahirkan di RS Prima Husada tidak hanya dari wilayah singosari melainkan dari luar wilayah Puskesmas singosari	1.Koordinasi dengan Puskesmas Ardimulyo 2. Koordinasi dengan Puskesmas Singosari 3. Koordinasi dengan Kabid yanmed, kepala instansi farmasi, Karu Neonatologi untuk pengadaan vaksin uvax-B	Tutut Dhora	
	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	IUD pasca lahir	1.Pemasangan IUD pasca lahir dan pasca curet pasien abortus 17 pasien dikarenakan pemasangan IUD berbayar jika dipasang dokter	1. Melakukan edukasi pasien inpartu, rencana SC,pasien abortus 2. Edukasi pasien dan penunggu di ruang tunggu poli kandungan oleh PJ KBRS	Ima,Dayu	

			2.IUD nova T alat+jasa dokter : 850.000 3. IUD coper T alat gratis, ada jasa dokter 400.000 4. Pemasangan IUD coper T oleh bidan gratis 5. Pasien memilih KB setelah nifas	3. Membuat flayer KB yang ditempatkan di ruang tunggu poli obgyn		
	Kelas Senam Hamil	Peserta senam hamil belum mencapai target	Kelas senam hamil di Prima Husada dilakukan 2 kali dalam satu bulan minggu ke 2 dan minggu ke 4 dengan target peserta setiap kelas 30 peserta,sehingga 1 bulan 60 peserta, pada bulan September peserta senam hamil 27 orang	1. Memberikan info kepada ibu hamil di poli Obgyn untuk melakukan senam hamil 2. Membagikan Flayer senam hamil di IG RS Prima Husada 3. Membuat video promosi senam hamil yang di share di IG RS dan di prima menyapa 4. Membuat Flayer promosi senam hamil yang di tempatkan di ruang tunggu poli obgyn	Ima,erico ,dayu	

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan Ponek bulan September 2025 disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang . Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Ketua Tim PONEK



dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Malang, 01 Oktober 2025
PLT Direktur Rumah Sakit
Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

